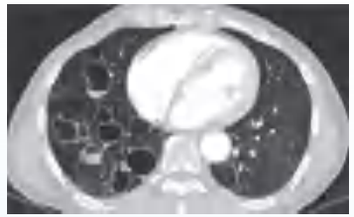
内科含诊断 支气管扩张症（含杵状指小结）★☆☆（0~3题）

诊断和治疗

- 多继发于支气管肺炎（麻疹 / 百日咳等）、慢支、肺结核
- 好发于左肺下叶
  干性支扩好发于上叶尖后段（与肺结核有关）
- 长期咳大量脓痰“痰盂”
  多有咯血和杵状指
  固定持久的湿啰音
  可能可能最可能（2018）
  - 脓痰：清除分泌物
    - 雾化吸入高渗生理盐水或乙酰半胱氨酸
    - 体位引流：头低臀部抬高
    - 排痰不宜过快以防窒息
  - 咯血
    - 50%~70%
    - 咯血量与疾病严重程度不完全相关
    - 干性支扩以反复咯血为唯一症状
    - 治疗（2025）
      - 量中：垂体后叶素或酚妥拉明
      - 量大（＞ 500ml/d 或＞ 100ml/ 次“五一”）：
        病变弥漫→介入栓塞支气管动脉
        病变局限→手术切除
- 合并急性感染（发热）——抗感染（2012、2018、2021、2026）
  - 无铜绿假单胞菌感染高危因素：针对流感嗜血杆菌
  - 有铜绿假单胞菌感染高危因素
    “按头窥探：他坐着排稀”
    - 住院、FEV_1 ＜ 30% 预计值等
    - 头孢他啶 / 哌酮 / 吡肟等三四代头孢
      哌拉西林 - 他唑巴坦
      亚胺培南 / 美罗培南等碳青霉烯类（不选厄他培南“恶心”）
      环丙沙星 / 左氧氟沙星等呼吸喹诺酮（不选诺氟沙星“懦夫”）
      妥布霉素等氨基糖苷类

金标准 -HRCT（2018）



多发薄壁囊腔、管壁增厚呈双轨征
部分见液平、印戒征、卷发征

杵状指小结（2016）“硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎”

- 支扩、慢性肺脓肿、慢性脓胸
  肺癌、间质性肺病
- 亚心炎
  法洛四联症
- 肝硬化
  炎症性肠病
- 系统性硬化症
  梅毒